ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２抗原定量検査における判定保留域の臨床的意義

小児領域における検討

◎鈴木 大智[1)]、池ヶ谷 佳寿子[1)]、谷藤 流空[1)]、大瀧 南海子[1)]、佐々木 克寿[1)]、望月 久仁子[1)]
静岡市立清水病院[1)]

【目的】COVID-19 において陽性・陰性の正確な判定は適切な感染対策を行う上で重要である。当院では HISCL-5000 SARS-CoV-2 Ag 試薬による COVID-19 検査において、現在カットオフインデックス（以下 C.O.I.）1.0～14.9 を判定保留と報告している。本研究では判定保留域に含まれる小児症例の特徴を解析し、臨床的意義を検討した。

【方法】2023/3～2026/4 に当院で SARS-CoV-2 抗原定量検査を実施した 15,785 例を対象とした。判定保留例を抽出し、年齢群別（0～5 歳、6～14 歳、15 歳以上）の判定保留率を比較した。比較にはFisherの正確確率検定を用いた。また、電子カルテから最終診断を調査し、COVID-19 陰性例をウイルス性呼吸器疾患群、細菌性呼吸器疾患群、その他疾患群に分類した。さらに、COVID-19 陽性例と陰性例で年齢、当日体温、最高体温および C.O.I.値を比較した。また、年齢、当日体温、最高体温および性別と C.O.I.値との関連を評価した。比較には Mann‑Whitney U 検定および Spearman 順位相関係数を用いた。統計解析には EZR1.68 を使用し、有意水準は p <0.05 とした。

【結果】全例のうち判定保留は 410 例（2.6%）であった。判定保留率は 0～5 歳で 8.4%、6～14 歳で 3.7%、15 歳以上で 2.1%であり、年齢群間で有意差を認めた（p <0.001）。0～5 歳は 15 歳以上と比較して判定保留となるオッズ比が 4.2 倍（95%CI：3.23‑5.41）であった。小児判定保留 103 例のうち COVID-19 陽性は 6 例（5.8%）、陰性は 97 例（94.2%）であった。陰性例ではウイルス性呼吸器疾患群が 77.3%を占めた。COVID-19 陽性例と陰性例の年齢、当日体温、最高体温および C.O.I.値に有意差は認められなかった。また、年齢、当日体温、最高体温および性別と C.O.I.値との間にも有意な相関を認めなかった。

【考察】判定保留域は乳幼児に多く認められた。小児判定保留例の多くは COVID-19 陰性であったが、COVID-19 陽性例も含まれていた。判定保留域を一律に陽性または陰性として扱うことは過剰診断あるいは見逃しにつながる可能性があり、追加検査や臨床情報を組み合わせて評価する運用の妥当性が示唆された。

連絡先：054-336-1111（内線：2614）